

# 反馈式饮食健康教育对肝癌并发低蛋白血症患者的影响

张利利 张 莉

【中图分类号】 R735.7 【文献标识码】 A 【文章编号】 2097-0196 (2025) 02-0127-04

【摘要】 目的:探讨反馈式饮食健康教育对肝癌并发低蛋白血症患者的饮食依从性及生活质量影响。方法:选取医院收治的 70 例肝癌并发低蛋白血症患者,应用随机数表法分为两组,对照组 35 例肝癌并发低蛋白血症患者应用常规饮食指导,观察组 35 例肝癌并发低蛋白血症患者护理期间引入反馈式饮食健康教育。比较两组患者护理后饮食依从性、护理管理前后营养指标、生活质量水平改善情况。结果:观察组患者饮食依从性显著高于对照组 ( $P < 0.05$ )。干预前,两组患者营养指标(白蛋白、前白蛋白)、生活质量评分相比,差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ );干预后,两组患者各项营养指标、生活质量评分均优于干预前 ( $P < 0.05$ ),且观察组患者各项营养指标、生活质量评分改善情况显著优于对照组 ( $P < 0.05$ )。结论:反馈式饮食健康教育能有效提高肝癌并发低蛋白血症患者饮食依从性及生活质量,改善患者营养水平。

【关键词】 反馈式饮食健康教育 肝癌 低蛋白血症 饮食依从性 生活质量

doi:10.20072/j.cnki.issn2097-0196.2025.02.040

肝癌发生后可导致一系列并发症,其中低蛋白血症是较为常见的一种。低蛋白血症不仅会影响患者的生理功能,还可能进一步加剧疾病的进展。因此,在肝癌并发低蛋白血症患者的治疗过程中,采取有效的干预措施尤其是饮食干预非常重要。反馈式饮食健康教育作为一种新兴的护理模式,通过将教育内容与患者的实际反馈相结合,旨在通过不断的反馈、调整,使患者更好地理解、遵循饮食指导,从而达到改善营养状况、提高生活质量的目的<sup>[1]</sup>。这一模式不仅强调对患者灌输饮食知识,更注重患者对饮食指导的接受度和执行度,通过定期的评估反馈,确保患者能够真正理解和实践科学的饮食管理。由于肝脏功能受损,患者往往面临蛋白质合成减少和消耗增加的问题,从而导致低蛋白血症发生。而合理的饮食管理,特别是摄入高蛋白饮食可以有效补充体内蛋白质,改善营养状况,从而有助于减轻症状、提高生活质量。然而,很多患者在面对复杂的饮食指导时,往往感到困惑,导致饮食计划难以执行,进而导致患者饮食依从性降低,影响了恢复效果。因此,将反馈式饮食健康教育应用于肝癌并发低蛋白血症患者的护理中具有积极意义<sup>[2-3]</sup>。因此,本文选取本院收治的 70 例肝癌并发低蛋白血症患者,探讨反馈式饮食健康教育对肝癌并发低蛋白血症患者的饮食依从性及生活质量影响,现报告如下:

## 1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2022 年 2 月-2023 年 2 月期间本院治疗的 70 例肝癌并发低蛋白血症患者作

为研究对象,应用随机数表法分为两组,对照组 35 例患者应用常规饮食指导,观察组 35 例患者护理期间引入反馈式饮食健康教育。观察组中男 18 例,女 17 例;年龄 37~78 岁,平均年龄 ( $63.25 \pm 5.98$ ) 岁。对照组中男 19 例,女 16 例;年龄 35~79 岁,平均年龄 ( $62.86 \pm 5.74$ ) 岁。两组患者一般资料比较,差异均无统计学意义 ( $P > 0.05$ ),具有可比性。本次研究经医院伦理委员会批准。①纳入标准:经病理证实均为原发性肝癌、低蛋白血症者;无药物依赖史或精神病史;患者神志清楚、沟通能力正常;临床资料完整;患者对本次调查知情同意。②排除标准:合并有严重心、脑、肾等疾病;不愿参与调查者;精神障碍者;妊娠、哺乳者。

## 1.2 护理方法

1.2.1 对照组 患者采用常规饮食指导,即向患者讲解日常饮食的类型、注意事项、加强饮食管理的重要性等;定期检测血清蛋白水平,观察患者的症状变化,如水肿、乏力等,以便及时调整治疗方案;保持患者的皮肤清洁干燥,避免皮肤破损,预防呼吸道、泌尿道等部位感染;根据患者的身体状况,鼓励患者适量运动,如散步、太极拳等,以增强体质和提高抗病能力,但注意避免过度劳累,以免加重病情;积极关注患者的心理状态,给予必要的心理疏导,帮助患者保持良好的心态,积极配合治疗。患者均连续干预 1 个月。

1.2.2 观察组 患者引入反馈式饮食健康教育,患者均连续干预 1 个月。

1.2.2.1 制定个体化饮食计划 对患者进行全面的评估,包括营养状况、饮食习惯、肝功能指标(如血清总蛋白、白蛋白水平)、体质指数(BMI)、消化吸收能力等,根据基线评估结果制定个体化

作者单位:蚌埠医科大学第一附属医院 安徽蚌埠 233000  
基金项目:2024 年度蚌埠医科大学科技项目自然科学类(编号:2024BBPY021)  
2024-11-25 收稿,2025-01-19 修回

的饮食计划。饮食计划中确保足够的能量摄入,同时富含优质蛋白质、维生素和矿物质,优质蛋白质食物包括鱼、肉、蛋类、牛奶和豆制品。维生素与矿物质食物包括新鲜水果(苹果、香蕉、猕猴桃、橙子等)和蔬菜(菠菜、胡萝卜、黄瓜等)。同时提供适量的碳水化合物,以维持血糖水平稳定,减少蛋白质的消耗,限制高脂肪食物的摄入,以减轻肝脏负担。

**1.2.2.2 实施反馈式饮食健康教育** ①详细记录日常饮食:护理人员积极为患者提供饮食日记模板,指导患者记录每日的饮食情况,包括食物的种类、摄入量、进食时间和进食后的感受。饮食日记包括早餐、午餐、晚餐和加餐的详细记录,以及进食后的身体状况(如饱腹感、疲劳程度、排便情况等)。要求患者每周或每两周提交一次饮食日记,由营养师或医生进行评估。根据评估结果,调整饮食计划。②加强营养教育指导:积极通过讲座、视频、手册等形式,向患者提供营养教育和指导,使患者深入了解饮食与健康的关系,掌握正确的饮食方法,重点讲解优质蛋白质的重要性,以及如何通过食物补充优质蛋白质。充分强调新鲜水果和蔬菜在饮食中的重要性,以及如何通过多样化饮食补充维生素和矿物质。另外是积极讲解碳水化合物和脂肪的作用,以及如何合理控制摄入量,以维持血糖水平稳定,减轻肝脏负担。③症状监测调整:要求患者每周测量体质量,记录体质量变化。体质量下降过快或水肿加重时,及时增加蛋白质摄入量。同时指导患者观察水肿和腹水的变化情况,如有加重,则及时就医,调整治疗方案。④心理支持:鼓励患者在饮食日记中记录自己的情绪变化,以便及时处理情绪问题。通过心理咨询、心理支持小组等形式,为患者提供心理支持,帮助患者缓解焦虑、抑郁等情绪问题。教授患者一些情绪管理技巧,如深呼吸、冥想、放松训练等,以缓解情绪压力。鼓励患者家人监督患者执行饮食计划,为患者提供心理支持。

**1.2.2.3 动态调整饮食计划** 鼓励患者积极关注自己的身体反应,如进食后的饱腹感、疲劳程度、排便情况等,以便及时调整饮食计划。如果患者感到饱腹感过强或消化不良,则适当减少食物摄入量,或选择更易消化的食物。如果患者感到疲劳加重,则可能是能量摄入不足或蛋白质消耗过多,可适当增加优质蛋白质的摄入量,以提高能量水平;如果患者出现便秘或腹泻等症状,可适当增加膳食纤维的摄入量。同时定期监测患者的肝功能指标和营养状况,如血清总蛋白、白蛋白水平、BMI等,及时调整饮食计划,如果患者的肝功能指

标出现异常,如血清总蛋白和白蛋白水平下降,则适当增加优质蛋白质的摄入量;如果患者的BMI过低或过高,则适当调整饮食结构,增加或减少能量摄入。另外是根据季节变化调整饮食,如夏季气温高,人体易出汗,适当增加水分和电解质的摄入量,同时选择清淡易消化的食物,以减轻肝脏负担;冬季气温低,应适当增加优质蛋白质和脂肪的摄入量,以提供足够的能量。

**1.3 观察指标** ①饮食依从性:饮食依从性评估按照Morisky依从性问卷(MMAS8)<sup>[4]</sup>,该量表分值范围0~8分,饮食依从性良好:8分,饮食依从性一般:6~7分,饮食依从性差:<6分。该问卷的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.74,具有较好的信度。②营养指标:营养指标包括白蛋白、前白蛋白。③生活质量:生活质量的判定则是通过生活质量测定量表<sup>[5]</sup>,该量表主要从生理、社会、心理、疼痛四个维度进行评分,单项分值0~100分,分值越高表示生活质量最高。该量表的Cronbach's  $\alpha$ 系数为0.76,具有较好的信度。

**1.4 统计学方法** 采用SPSS 22.0统计软件分析数据,符合正态分布的计量资料采用( $\bar{x} \pm s$ )表示,两组间比较采用独立样本 $t$ 检验,护理前后比较采用配对 $t$ 检验;计数资料以相对数表示,采用 $\chi^2$ 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

## 2 结果

**2.1 两组患者饮食依从性比较** 观察组患者饮食依从性显著高于对照组,差异具有统计学意义( $P < 0.05$ )。见表1。

表1 两组患者饮食依从性比较 例(%)

| 组别       | $n$ | 完全依从 | 部分依从 | 不依从 | 依从率    |
|----------|-----|------|------|-----|--------|
| 观察组      | 35  | 31   | 3    | 1   | 97.14% |
| 对照组      | 35  | 22   | 5    | 8   | 77.14% |
| $\chi^2$ |     |      |      |     | 4.590  |
| $P$      |     |      |      |     | 0.032  |

**2.2 两组患者营养指标改善情况比较** 干预前,两组患者营养指标(白蛋白、前白蛋白)相比,差异无统计学意义( $P > 0.05$ );干预后,两组患者白蛋白、前白蛋白优于干预前( $P < 0.05$ ),且观察组患者营养指标改善情况显著优于对照组( $P < 0.05$ )。见表2。

表2 两组患者营养指标改善情况比较 ( $\bar{x} \pm s$ )

| 组别  | $n$ | 白蛋白(g/L)         |                   | 前白蛋白(mmol/L)     |                   |
|-----|-----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |     | 干预前              | 干预后               | 干预前              | 干预后               |
| 观察组 | 35  | 35.36 $\pm$ 3.14 | 46.15 $\pm$ 4.25* | 31.87 $\pm$ 2.36 | 39.72 $\pm$ 3.51* |
| 对照组 | 35  | 35.39 $\pm$ 3.08 | 42.18 $\pm$ 4.57* | 31.56 $\pm$ 2.69 | 36.48 $\pm$ 2.47* |
| $t$ |     | 0.040            | 3.763             | 0.513            | 4.466             |
| $P$ |     | 0.968            | < 0.001           | 0.610            | < 0.001           |

注:与同组干预前后比较,\* $P < 0.05$

**2.3 两组患者生活质量改善情况比较** 干预前,两组患者生活质量评分相比,差异无统计学意义



( $P>0.05$ ) ; 干预后, 两组患者生活质量评分均优于干预前 ( $P<0.05$ ) , 且观察组患者生活质量评分改善情况显著优于对照组, 差异具有统计学意义 ( $P<0.05$ ) 。见表 3。

表 3 两组患者生活质量改善情况比较 ( $\bar{x}\pm s$ , 分)

| 组别  | n  | 生理评分       |             | 社会评分       |             | 心理评分       |             | 疼痛评分       |             |
|-----|----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|     |    | 干预前        | 干预后         | 干预前        | 干预后         | 干预前        | 干预后         | 干预前        | 干预后         |
| 观察组 | 35 | 66.48±3.45 | 88.06±5.83* | 63.34±3.18 | 87.52±5.78* | 55.09±3.41 | 85.59±5.26* | 53.48±3.61 | 84.27±5.28* |
| 对照组 | 35 | 66.37±3.38 | 77.04±4.59* | 63.25±3.63 | 77.43±4.56* | 55.27±3.18 | 72.13±4.58* | 53.74±3.49 | 75.64±4.39* |
| t   |    | 0.135      | 8.786       | 0.110      | 8.108       | 0.228      | 11.417      | 0.306      | 7.435       |
| P   |    | 0.893      | <0.001      | 0.913      | <0.001      | 0.820      | <0.001      | 0.760      | <0.001      |

注: 与同组干预前后比较, \* $P<0.05$

3 讨论

肝癌常伴随复杂的并发症, 低蛋白血症便是较为常见的一种。低蛋白血症不仅会影响患者的营养状况, 还可导致水肿、腹水等症状出现, 进一步加重患者的身体负担。因此在肝癌并发低蛋白血症的治疗过程中, 饮食管理至关重要的角色。然而, 传统的饮食指导方法往往缺乏个性化, 难以满足患者的实际需求。反馈式饮食健康教育强调患者与医疗团队的紧密合作, 通过定期记录饮食、症状监测和营养评估, 医疗团队能及时了解患者的饮食情况和身体状况, 并根据反馈情况进行个性化的饮食调整, 帮助患者更好地掌握饮食管理的技巧, 增强患者自我管理能力和提高饮食依从性<sup>[6-7]</sup>。

本次研究中, 观察组患者饮食依从性显著高于对照组 ( $P<0.05$ ) , 且观察组患者各项营养指标、生活质量评分改善情况显著优于对照组 ( $P<0.05$ ) , 可见反馈式饮食健康教育能有效提高肝癌并发低蛋白血症患者饮食依从性及生活质量, 改善患者营养水平。分析其原因, 反馈式饮食健康教育通过制定个性化的饮食计划, 确保患者摄入足够的优质蛋白质、维生素和矿物质, 对于促进肝脏功能恢复、提高血浆蛋白质水平至关重要。通过定期的饮食记录和营养评估, 医疗团队也能够及时了解患者的营养状况, 并根据反馈情况进行针对性的饮食调整, 确保患者获得均衡的营养摄入, 从而有效改善营养指标。在提升生活质量方面, 反馈式饮食健康教育通过改善患者的营养状况, 有助于缓解患者身体不适症状, 如水肿、腹水等, 进而逐步恢复患者的身体功能, 提升生活质量; 反馈式饮食健康教育充分注重患者的心理支持<sup>[8-9]</sup>, 通过心理咨询、心理支持小组等形式, 为患者提供心理支持, 帮助患者缓解焦虑、抑郁等情绪问题, 从而有助于增强患者的自信心, 提高患者生活质量。在提升依从性方面, 反馈式饮食健康教育通过制定个性化的饮食计划, 确保饮食方案符合患者的口味、偏好, 从而有助于增加患者的饮食兴趣, 提高其饮食依从性<sup>[10]</sup>。而通过定期的讲座、手册和视频等多种形式, 向患者普及营养知识和饮食管理技巧, 有助于提高患者的营养意识、自我管

理能力, 使患者能够更好地理解饮食计划的重要性, 从而增强患者对饮食计划的依从性。

综上所述, 反馈式饮食健康教育能有效提高肝癌并发低蛋白血症患者饮食依从性及生活质量, 改善患者营养水平。

参考文献

[1] 兰怡昕, 邱小琴, 黄兰青, 等. 老年慢性心力衰竭患者发生低蛋白血症的影响因素分析及其风险预测列线图模型构建及验证[J]. 实用心脑血管病杂志, 2024, 32(5): 42-48.

[2] 张梅, 方萍, 杨亮, 等. 基于风险评估的分级护理联合感控督导对血液透析患者中心静脉导管相关性血路感染的影响[J]. 护士进修杂志, 2022, 37(17): 1598-1602.

[3] 邱水晶, 胡占嵩, 屠莹, 等. 非体外循环冠状动脉搭桥术后低蛋白血症与补充人血白蛋白对患者急性肾损伤的影响[J]. 中国药房, 2022, 33(14): 1759-1763.

[4] 代莉亚, 王晓英, 梁利杰. 1M3S护理管理模式对原发性肝癌手术患者手术结局、术后肠道微生态分布及免疫功能的影响[J]. 国际护理学杂志, 2023, 42(15): 2808-2811.

[5] 刘春莉, 王雪梅. 基于微信平台的同伴教育护理模式对肝癌介入患者术后心理、自我护理能力及生活品质的影响[J]. 护理实践与研究, 2021, 18(11): 1686-1689.

[6] SPADACCINI, MARCO, CANZIANI, et al. What gastroenterologists should know about SARS-CoV 2 vaccine: World Endoscopy Organization perspective [J]. UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY JOURNAL, 2021, 9(7): 787-796.

[7] 张亮, 胡舟朝, 张晓东, 等. 基于Orem自理理论的精准健康教育对肝癌介入治疗患者自理能力、社会功能和生活质量的影响[J]. 中国基层医药, 2024, 31(8): 1228-1231.

[8] 姚媛淑, 朱英娥, 裔馨颖, 等. 基于适时理论的全周期护理模式对改善肝癌靶向治疗患者院后症状困扰及不良反应的品管圈实践[J]. 国际护理学杂志, 2024, 43(18): 3356-3360.

[9] 沈传宇,吕平,姜乐乐,等.基于加速康复外科理念下的护理健康教育路径在腹腔镜肝癌切除术患者术后恢复中的应用[J].国际护理学杂志,2024,43(7):1163-1168.

[10] 连亚强,张芳平,刘林梅,等.信息-动机-行为技巧模型护理干预对肝癌晚期病人心理、自我效能感和生活质量的影响[J].护理研究,2022,36(19):3566-3569.

## Effect of feedback diet health education on patients with hepatocellular carcinoma complicated with hypoproteinemia

The First Affiliated Hospital of Bengbu Medical University, Bengbu 233000, Anhui

ZHANG Li-li, ZHANG Li

**Abstract:***Objective:*To analyze the effects of feedback diet health education on dietary compliance and quality of life in patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia. *Methods:*70 patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia in our hospital were selected and divided into two groups by random number table method. 35 patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia in the control group received conventional diet guidance, and 35 patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia in the observation group received feedback diet health education during nursing. The dietary compliance, nutritional indexes and life quality improvement of patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia after nursing were compared between the two groups. *Results:*The dietary compliance of patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia in observation group was significantly higher than that in control group ( $P < 0.05$ ). Before intervention, there were no significant differences in nutritional indexes (albumin, prealbumin) and quality of life scores between the two groups ( $P > 0.05$ ). After intervention, the nutritional indexes and life quality scores of the two groups were better than those before intervention ( $P < 0.05$ ), and the improvement of the nutritional indexes and life quality scores of the observation group was significantly better than that of the control group ( $P < 0.05$ ). *Conclusion:*Feedback diet health education can effectively improve the dietary compliance and quality of life of patients with liver cancer complicated with hypoproteinemia, and promote the improvement of the nutritional level of patients.

**Key Words:**feedback diet health education; liver cancer; hypoproteinemia; dietary compliance; quality of life

(责任编辑:孙玉花)

(上接第123页)

[7] 奚兴,郭桂芳,孙静.中文版Tilburg衰弱评估量表的信效度研究[J].护理学报,2013,20(16):1-5.

[8] 吕繁,顾媛.家庭APGAR问卷及其临床应用[J].国外医学(医院管理分册),1995(2):56-59.

[9] 李志宏,赵志艳,哈琳,等.心血管内科老年跌倒高危病人警觉度现状及影响因素[J].护理研究,2024,38(20):3730-3734.

[10] 郭晓贝,王颖,杨雪柯,等.基于患者参与框架的

住院老年患者跌倒预防干预策略的实施[J].护理学杂志,2021,36(1):50-53.

[11] HOEL RW, GIDDINGS CONNOLLY RM, TAKAHASHI P Y. Polypharmacy Management in Older Patients[J].Mayo Clinic Proceedings,2021, 96(1):242-256.

[12] 周德定,徐乃婷,高宁,等.应用结构方程模型分析上海市中心城区老年人跌倒的影响因素[J].环境与职业医学,2019,36(8):703-709.

## Analysis of the current situation of fall alertness and factors affecting fall alertness in elderly patients with multiple chronic diseases

1.Graduate School,Wannan Medical College,Wuhu 241001,Anhui

WU Meng-lan<sup>1</sup>, PAN Ai-hong<sup>2</sup>, ZHANG Ying<sup>1</sup>, WU Min<sup>1</sup>, LIU Rui<sup>3</sup>

**Abstract:***Objective:*To investigate the current status of fall alertness in elderly patients with multiple chronic diseases and analyze the influencing factors, in order to provide a theoretical basis for the development of relevant interventions. *Methods:*A questionnaire survey of 383 elderly patients with multiple chronic diseases admitted to a tertiary hospital was conducted using the General Information Questionnaire, the Falls Alertness Scale, the Chinese version of the Tilburg Frailty Scale, the Family APGAR Index Scale, and the Modified Falls Effectiveness Scale. *Results:*The fall alertness score of elderly patients with multiple chronic diseases was ( $57.26 \pm 3.94$ ), and 116 patients (30.28%) had high fall alertness. The results of multivariate linear regression showed that age, literacy, residence, average monthly income, number of chronic disease types, self-assessed environmental safety, history of falls, frailty, family APGAR, and fear of falling were the influencing factors of fall alertness in elderly patients with chronic diseases ( $P < 0.05$ ). *Conclusion:*The fall alertness of elderly patients with multiple chronic diseases is at a moderately low level. Clinical workers should focus on the fall alertness of the above groups and provide targeted interventions to reduce the incidence of falls.

**Key Words:**the elderly;multiple chronic diseases;fall alertness;falling

(责任编辑:张琴)